

Anemia · VCM e investigação dirigida

Comece pelo VCM e pelos reticulócitos. Anemia microcítica pede ferro/talassemia; macrocítica, B12/folato/álcool; normocítica, perda aguda, doença crônica ou hemólise/medula.

Ferritina com nuance

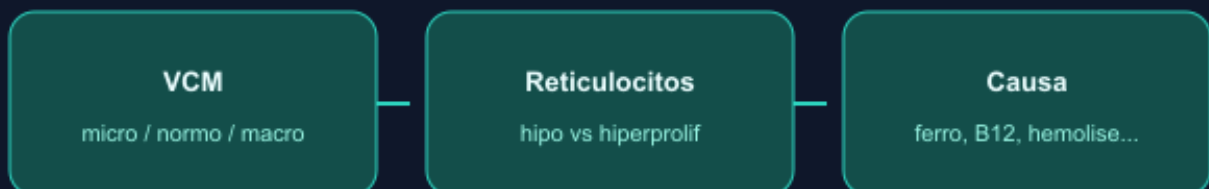
Dica - Ferritina com nuance

Ferritina baixa confirma deficiência de ferro. Ferritina 'normal' na inflamação não exclui — use saturação de transferrina e ferro sérico no contexto clínico.

Fluxo clássico de R1: classifique !' veja se há resposta medular !' escolha o painel etiológico.

Raciocínio da anemia

VCM -> reticulocitos -> causa



Achados que caem em prova

- Ferropênica: VCM!“, ferritina!“; investigar sangramento (GI, menstrual)
- Talassemia menor: VCM muito baixo com anemia leve e RDW relativamente estável
- B12: macrocitose, neuropatia, LDH!“, hipersegmentação; repor parenteral se grave/neurológico
- Hemólise: retic!“, LDH!“, bilirrubina indireta!“, haptoglobina!“

Microcítica — diferenciação rápida

Achado | Ferropênica | Talassemia menor

Anemia | Variável / sintomática | Leve

VCM | !“ | !!“ desproporcional

Ferritina | Baixa | Normal/alta

RDW | Alto | Normal/leve!“

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não feche 'anemia de doença crônica' sem excluir ferro e sangramento oculto quando houver indício. Em idoso com ferropenia, pense em neoplasia GI até prova em contrário.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Classificar pelo VCM e interpretar ferritina/ferro/TIBC separa ferropenia de anemia de doença crônica e macro/micro padrões.

Micro × normo × macro direciona a propedêutica.

Classificacao por VCM

Primeiro ramo



Ferritina baixa fecha ferropenia; na ACD ferritina normal/alta com ferro sérico baixo.

Ferropenia vs ACD

Labs classicos

Ferropenia: ferritina baixa

Fe

Ferropenia: TIBC/transferrina alta

Fe

ACD: ferritina N/alta

ACD

ACD: TIBC baixo/normal

ACD

Ferro baixo + TIBC alto + ferritina baixa = ferropenia

Painel de ferro

| Ferropenia | Doença crônica

Ferro sérico | !" | !"

Ferritina | !" | N/!"

TIBC | !" | !"/N

Saturação transferrina | !" | !"/N

Achados que fecham prova

- Ferropenia no homem/mulher pós-menopausa: investigar perda GI
- B12: VCM!'", neutrófilos hipersegmentados, neuropatia, LDH!'/BID!'" se grave
- Hemólise: retic!'", LDH!'", haptó!'", BID!'" ± Coombs
- Talassemia menor: microcitose desproporcional, RDW mais estável, ferro ok

Reticulócitos

Dica - Reticulócitos

Baixos = hipoproliferativa (falta de substrato/medula). Altos = perda ou hemólise.

